

13/08

104

INDICADO POR: Dr. Carlos Leite

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

APARECIDA SANTANA BORGES

IDADE: 68 PESO: 73 ALTURA: 1,53 PROFISSÃO: Advogada

SINTOMAS: Sono fragmentado; Dorco; Acorda cansada.

QUEIXAS: Déficit memória; Dorme mal; peradelor (repocamento/queda)

MEDICAMENTOS: Rosuvastatina; selozok. → quito - n lembra
Desvenlafaxina (depensa)

MÉDICO: Dr. Carlos Leite (cardio)

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana. pilates - musculação.

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23h HORA QUE ACORDA: 03h n dorme mais,

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: ☒ S () N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N 1x semana (nelor)FUMO: ☒ S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: parou há 22 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 15,4 SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dinite aconex (Hntb/ nolo)

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Dr. Carlos Leite

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 CI/CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

for uma crise de ausência em Abril/2025.

11/07/2025 → Neurol Dr. Pedro Valério n tem mais exames

Sugere tratar sono.

Haliacp Auto 4 a 10 cmH₂O.

Másc N30i (S).

28/07/25 P= 7,5 cmH₂O -lexenthl 9,6 cmH₂O.

IAH = 6,0 e/h AO: 5,1 e/h

muco = 5h 58 min

fuga = 35 l/min.

Demora dormir

boca seca; relutância mairnal

Auto Auto 6 a 8 cmH₂O.

Dra. Maria Solange Rampani

CRO-SP 19.594

Especialista em Prótese Dentária

Especialista em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial

Mestre e Doutora pela UNESP

Odontologia em Medicina do Sono (Certificada pela Assoc. Bras. Sono)

Odontologia ampliada pela Antroposofia

odontologia especializada

Ao Dr. Alain Dutra

Relatório de APARECIDA SANTANA BORGES - 65a

A paciente apresenta SAOS moderada (IDR= 15,4/h) e roncopia. Nos exames de avaliação qualitativa pôde ser observada perda na qualidade de vida evidenciando ainda mais a necessidade de tratamento (Epworth -sonolência diurna= 20, normal até 9; Chalder - fadiga = 6, normal até 4; Fletcher & Luckert - distúrbios do sono = 2,13, normal até 1,0).

Ao exame clínico as condições dentárias e periodontais, além da capacidade de avanço mandibular, não contraindicam o uso de AIOam (Aparelho Intra-Oral de avanço mandibular) que é considerado padrão ouro nesse tipo de patologia no grau apresentado.

Após análise de Documentação Ortodôntica específica será possível estabelecer se realmente será oportuna essa indicação e qual tipo de aparelho.

Fico assim no aguardo de seu consentimento para seguimento do tratamento.

Sem mais, à disposição,


Dra. Maria Solange Rampani
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 19.594

São José dos Campos, 08 de Junho de 2022.

Rua Euclides Miragaia, 145 / 1208 - Helbor Downtown - Centro - CEP 12.245-820 - São José dos Campos, SP. Fones: (12) 3921.2073 - 98823.2073 - marta.rampani@gmail.com